

고지혈증약(스타틴), 얼마나 센가요?

같은 스타틴이라도 **종류와 용량**에 따라 나뉘는 콜레스테롤(LDL)을 약 **22~55%**까지 낮춥니다. 중요한 것은 '상표'가 아니라 **강도 등급(고·중·저)**입니다 — 같은 등급이면 효과도 비슷합니다.

한눈에 보는 강도 등급

고강도 (강한 약) ≥ 50% LDL 감소 — 로수바·아토르바 고용량	중강도 30~49% 대부분의 표준 용량	저강도 < 30% 저용량·약한 성분	용량 2배 올리면 + 6% 만 더 감소 (6% 규칙)
---	------------------------------------	-------------------------------------	--

스타틴 종류·용량별 LDL 콜레스테롤 감소율 (강한 순)

로수바스타틴 40mg 크레스토 등 · 고강도	55% ↓
로수바스타틴 20mg 고강도	52% ↓
아토르바스타틴 40~80mg 리피토 등 · 고강도	~51% ↓
로수바스타틴 10mg 중강도	46% ↓
아토르바스타틴 20mg 중강도	43% ↓
피타바스타틴 2~4mg 리바로 등 · 중강도	~41% ↓
심바스타틴 40mg 중강도	39% ↓
아토르바스타틴 10mg 중강도	37% ↓
프라바스타틴 40mg 메바로친 등 · 중강도 경계	30% ↓
심바스타틴·프라바스타틴 저용량 저강도	~28% ↓

■ 고강도 (≥50%) ■ 중강도 (30~49%) ■ 저강도 (<30%) * 막대 길이 = LDL 감소율에 비례 · 근거: STELLAR(Jones 2003)·ACC/AHA 2018

꼭 기억할 두 가지

① 무작정 증량보다 '적정 강도'

6% 규칙 — 용량을 2배로 올려도 LDL은 약 **6%p**만 더 떨어집니다.
고용량 부작용(근육통·간수치)이 걱정되면, 증량 대신 **강도 등급에 맞는 약**을 고르는 것이 합리적입니다.

② 더 낮춰야 하면 '병용'

스타틴만으로 목표 미달 시 **에제티미브**를 더하면 LDL을 추가로 약 **18~25% ↓**.
스타틴 40mg + 에제티미브 병용은 심혈관 사건도 줄였습니다 (IMPROVE-IT 2015).

상표보다 '강도 등급'이 중요합니다

심혈관 위험을 줄이는 힘은 **LDL을 얼마나 낮추는가**에 달려 있습니다. 같은 **고강도**라면 브랜드가 달라도 효과는 비슷합니다. 내 위험도(관상동맥질환·당뇨 등)에 맞는 **목표 LDL**을 정하고, 그에 맞는 강도를 선택하는 것이 핵심입니다. **자동주스**는 일부 스타틴 농도를 높일 수 있어 주의하세요.

